

DERMATOSIS AMPOLLOSAS

María Jesús Suarez valladares

INTRODUCCIÓN

Una historia clínica bien orientada y un exámen físico adecuado van a ser cruciales para identificar el origen de las lesiones y poder plantear un correcto tratamiento.

A continuación hablaremos de las enfermedades ampollosas, que agrupan un conjunto de patologías muy distintas, la mayoría de causa autoinmune, que tienen en común la formación de ampollas. Estas ampollas ocurren por un despegamiento de la epidermis por la formación de anticuerpos contra las proteínas que intervienen en las uniones intercelulares.

En la tabla se muestran algunas de las enfermedades cutáneas que cursan con ampollas o vesículas que, más frecuentemente, podemos observar en urgencias.

- La aparición de ampollas o vesículas en un paciente pueden tener múltiples causas, lo más importante es realizar una historia clínica exhaustiva que nos oriente hacia el posible origen de las lesiones.
- Hay que prestar especial importancia a la ingesta de fármacos nuevos, historia de traumatismos o quemaduras, edad del paciente, localización, distribución (piel y/o mucosas) y presencia de síntomas acompañantes.
- Es necesario realizar una biopsia diagnóstica (incluso previo a la instauración de tratamiento) a todas las enfermedades ampollosas para identificarlas y poder tratarlas correctamente.
- Se puede manejar con corticoides tópicos, dejando los tratamientos sistémicos para pacientes con un diagnóstico de certeza o brotes muy extensos.

Datos clínicos	Posible diagnóstico	Manejo
¿Placas con ampolla en periferia? ¿Diseminación rápida? ¿Costra color miel?	Impétigo ampollar	Antibiótico tópico en formas localizadas u oral si extenso
¿vesículas agrupadas en racimo? ¿Mucosa oral o genital/nariz/lumbo-sacra? Recurrencias	Infección VHS (virus herpes simple)	Antivírico sistémico si importante extensión. Tratamiento profilaxis si > 1 brote/mes
¿Dolor? ¿Placa eritemato-edemaosa + vesículas agrupadas? ¿Trayecto metamérico?	Herpes Zóster	Antivírico sistémico (72h iniciales) Sulfato de Zinc. Afectación punta nasal u ojo, derivar OFTALMOLOGÍA
¿Prurito incoercible de predominio nocturno? ¿Afectación convivientes? ¿Excoriaciones por rascado? ¿Vesículas y surcos interdigitales?	Escabiosis	Permetrina 5% (repetir a la semana) Tratamiento convivientes y fómites
¿Fármacos? ¿Exantema inicial? ¿Mal estado general?	Síndrome Stevens-Johnson / Necrolisis epidérmica tóxica	Urgencias especialista dermatología +/- UCI.
¿vesículas claras en laterales de dedos o plantas? ¿Prurito intenso? ¿Recidiva de brotes?	Eccema dishidrótico	Corticoide tópico de alta potencia (noches oclusión) Reducir sudoración.

Datos clínicos	Posible diagnóstico	Manejo
¿Edad avanzada? ¿Fármacos? ¿Neoplasia? ¿Afectación de mucosa oral?	Enfermedades ampollosas autoinmunes (Pénfigo – Penfigoide)	Derivar al dermatólogo

DIAGNÓSTICO

Enfermedades ampollosas autoinmunes

Pénfigo

El pénfigo es una enfermedad producida por la formación de unos anticuerpos (IgG) contra las desmogleinas 1 y 3 de la epidermis provocando una formación de ampollas que pueden afectar a mucosa oral y piel.

Son unas ampollas intraepidérmicas flácidas (que se rompen fácilmente) sobre piel sana y típicamente presentan un signo de Nikolsky positivo (despegamiento de la piel sana por fricción).

El diagnóstico es clínico pero precisa una biopsia de confirmación, además de identificar la presencia de anticuerpos anti desmogleina I y III en sangre (los más frecuentes).

La forma más frecuente es el pénfigo vulgar, que suele iniciar con lesiones en mucosas (Figura 1b) y posteriormente extenderse al resto del cuerpo (Figura 1a). Existen otros tipos menos graves como el superficial, el gravídico o el desencadenado por fármacos.

Ante un paciente en urgencias con sospecha de pénfigo, lo más importante es la reposición hidroelectrolítica y evitar la sobreinfección, ya que se trata de pacientes con grandes áreas denudadas. El tratamiento de elección inicial serán los corticoides de alta potencia tópicos en formas localizadas u orales en casos extensos (siempre que sea posible tras la tener una confirmación histológica).

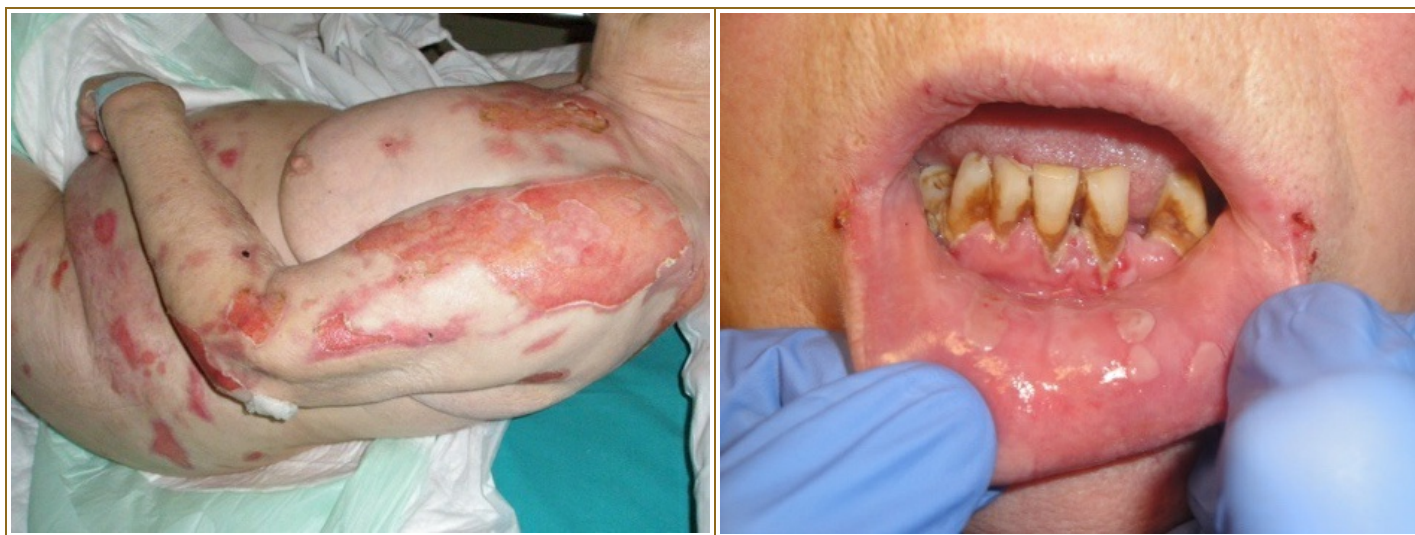


Figura 1a. Áreas denudadas extensas en las extremidades y torax de un paciente con pénfigo vulgar. 1b. Afectación oral del pénfigo con ampollas y áreas denudadas en mucosa.

Penfigoide ampolloso

Se trata de una entidad frecuente en personas mayores, donde hay una producción de anticuerpos anti-bp180 dirigidos contra los hemidesmosomas de la membrana basal epidérmica.

Clínicamente los pacientes refieren intenso prurito con la posterior formación de ampollas tensas sobre una piel eritematosa. No tienen signo de Nikolsky y no suele afectar a mucosas. Para su diagnóstico se precisa una biopsia de confirmación con inmunofluorescencia directa para identificar depósitos de IgG y C3 en membrana basal).

Cursa en brotes y suelen responder a los tratamientos tópicos con corticoides de alta potencia. En ocasiones se pueden asociar antihistamínicos orales para el control del prurito. Su pronóstico es más favorable que el pénfigo.



Figura 2. Ampollas tensas sobre piel sana en extremidad inferior de un paciente con un penfigoide ampolloso. Las lesiones suelen ser muy pruriginosas.

Penfigoide del embarazo o Herpes Gestationis

Es una enfermedad poco frecuente típica de mujeres embarazadas que puede iniciarse como un prurito en las primeras semanas del embarazo para dar paso a unas ampollas de predominio periumbilical y zonas proximales de extremidades. No suele existir afectación mucosa. El cuadro tiende a mejorar las últimas semanas del embarazo y empeorar 3-4 meses después del parto. El cuadro se puede repetir en posteriores embarazos con una presentación precoz y más severa. Para su diagnóstico es importante tomar una biopsia que confirme la presencia de anticuerpos en membrana basal. El manejo durante el embarazo será con corticoides tópicos y antihistamínicos orales, reservando otros fármacos para el periodo del puerperio.

Dermatitis herpetiforme

Es una enfermedad autoinmune frecuentemente asociada a enfermedad celiaca o sensibilidad al gluten. Se caracteriza por lesiones tipo vesícula muy pruriginosas con una distribución simétrica en glúteos, codos, sacro, rodillas... muchas veces solo se aprecian escoriaciones. No suele afectar a mucosas. El tratamiento consiste en realizar una dieta exenta de gluten y sino se controla asociar sulfonas.

Otras enfermedades ampollosas

Virus Herpes

Tanto el herpes simple como el varicela-zóster pueden formar lesiones vesiculosas de diferente distribución según el organismo implicado, además se pueden acompañar de un pródromos e intenso dolor. Se debe de manejar con antivirales orales.

Impétigo Ampolloso

Es una infección causada por el *Staphylococcus Aereus*, que causa unas ampollas flácidas de contenido purulento que rápidamente se rompen dejando erosiones superficiales. Suele afectar a zonas periorificiales y afectar a convivientes. Su tratamiento es con antibióticos orales.

Enfermedad Mano-Pie-Boca

Infección por Coxsackie que típicamente afecta a bebés y niños pequeños con sintomatología general de fiebre, dolor faríngeo y lesiones ampollosas en manos y pies.

Traumatismos

Ampollas causadas por quemaduras o por un apoyo prolongado de personas que permanecen inmóviles durante mucho tiempo, suelen ser la base de las úlceras.

Eccemas

Cuando los eccemas son muy agudos pueden presentar ampollas y/o vesículas con contenido seroso. Aparece típicamente en los eccema dishidróticos

Fitofotodermatosis

Existen algunas plantas (higuera o cítricos) que pueden sensibilizar la piel tras el contacto con ellas, provocando que una exposición solar cause lesiones tipo quemadura con formación de ampollas.

Toxicodermias

Algunas reacciones cutáneas a fármacos pueden provocar ampollas, entre ellas debemos diferenciar el eritema exudativo multiforme, el síndrome de Steven-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica. Todos precisan de un diagnóstico y tratamiento precoz para evitar complicaciones con fatal desenlace.

TRATAMIENTO

Recomendaciones prácticas en urgencias ante un paciente con lesiones ampollosas.

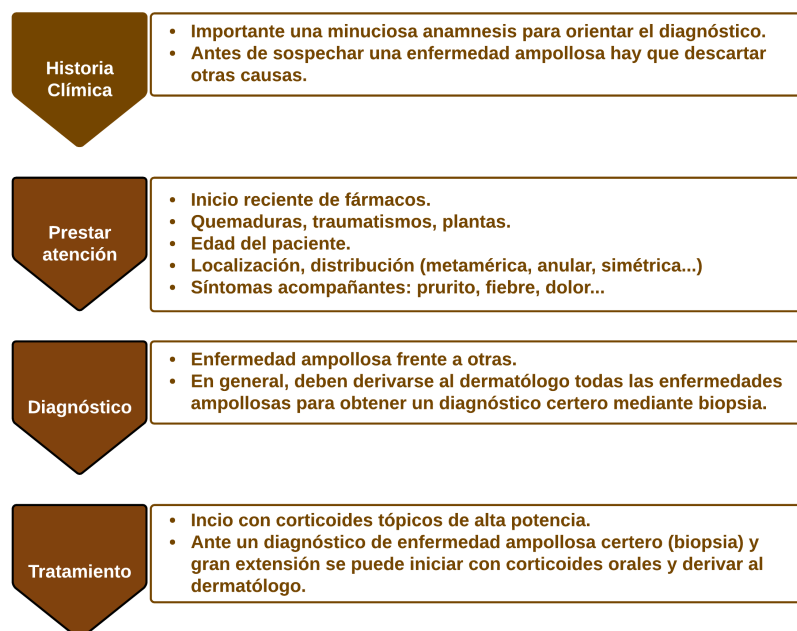


Figura 3. Algoritmo de manejo en urgencias ante un paciente con lesiones ampollosas

BIBLIOGRAFÍA

- Kershenovich R, Hodak E, mimouni D. Diagnosis and classification of pemphigus and bullous pemphigoid. Autoimmun Rev. 2014;13(4-5):477-81.

- Sánchez-Pérez J, García-Diez A. Pénfigo. Actas Dermosifiliogr. 2005;96(6):329-56.
- Suárez-Fernández R, España-Alonso A, Herrero-González JE, Mascaró-Galy JM. Manejo práctico de las enfermedades ampollosas autoinmnes más frecuentes. Actas Dermosifiliogr. 2008;99(6):441-55.